EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 79599
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-02-26 12:25:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIA MERCEDES ARRIAGADA MORAGA			RUN	: 6.135.126-4
F.Nac	: 28-11-1951	Edad	: 72 AÑOS, 2 MESES	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	:		
Fecha Ingreso	: 2024-02-20	Fecha Egreso	: 2024-02-26 12:25:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I61.4-HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA EN CEREBRO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

- HIC lobar fronto cingulada derecha. Obs hipertensiva
- Emergencia hipertensiva
- Antecedentes: - Hipertensión arterial - Dislipidemia - Poliartrosis - TEC grave en juventud

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I61-HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Antecedentes mórbidos:
- Hipertensión arterial
- Dislipidemia
- Poliartrosis
- TEC grave en juventud

Antecedentes quirúrgicos:
- Protesis de cadera bilateral.

Alergias:
- Sin antecedentes de alergia a medicamentos

Medicamentos:
- Atorvastatina 20 mg, 1 comp al día, VO
- Enalapril 10 mg, 1 comp cada 12 horas, VO
- Hidroclorotiazida 50 mg, 1/2 comp al día, VO
- Paracetamol 500 mg, 2 comp cada 12 horas, VO
- Tramadol 50 mg, 1 comp cada 12 horas
- Clonazepam 2 mg, 1/2 comp por noche

Habitos:
- OH: (-)
- Tabaco: (-)

- Drogas (-)
Social:
- San Carlos

Diestro mRS 2
Cadro de inicio el 19/02/24 consistente en desorientación cefalea, y alteración de la marcha con caida por debilidad crural izquierda por lo que consulta en HSC.
Al ingreso con FC 66 lpm, PA 190/70 mmHg, T° 36.6°C, Sat 96% ambiental, HGT 123 mg/dL. Al examen se describe "sin déficit motor". Se realizó estudio complementario con TC de encéfalo en que se constata hemorragia aguda fronto cingulada derecha de 3.2 cc y encefalomalacia secuelar frontal bilateral y temporal anterior derecho. En examenes de laboratorio sin plaquetopenia ni discoagulopatía. No se presentó a neurólogo de turno, se intenta ingresar a sala básica.
Se toma conocimiento del caso el 20/02/24 a las 7:15 horas, paciente en buenas condiciones con mal control de PA, afebril, sin apremio ventilatorio. En cuanto a lo neurológico mas confusa respecto a lo descrito por personal al ingreso. Se indican bolos sucesivos de Urapidil y posteriormente BIC
Se presenta caso a UTI y se acepta ingreso para medición invasiva de PA, vigilancia y neuroprotección.
Se mantiene en UTI hasta el 22/02/24 cuando se logra destete de BIC urapidil. y se mantiene con esquema de antihipertensivos orales sin necesidad de rescate. En monitorización con salva de FA con RVR autolimitadas.
Control con angioTC de encéfalo sin cambios en volumen de hematoma y sin alteraciones vasculares arteriales o venosas de relevancia.
En cuanto a la rehabilitación con ingesta completa y bien tolerada asistida consistencia papilla. Y logra bipedestar con asistencia de 2 operadores.
Considerando buen control de presión arterial, sin fluctuación neurológica, buena tolerancia a la rehabilitación. Se plantea en conjunto con familiar, hospitalización domiciliaria.

INDICACIONES AL ALTA

1. Régimen hiposódico consistencia papilla. Asistido, lento, fraccionado.
2. Amlodipino 10 mg, 1 comp al día, vía oral.
3. Losartan 50 mg, 1 comp cada 12 horas, vía oral.
4. Hidroclorotiazida 50 mg, 1 comp al día, vía oral.
5. Hidralazina 50 mg, 2 comp cada 8 horas, vía oral.
6. Clonazepam 2 mg, 1/2 comp por noche, vía oral.
7. Quetiapina 25 mg, 1/2 comp SOS por noche, vía oral.
8. Kinesioterapia motora
9. Seguimiento fonoaudiología.
10. Control en CAE de HSC neurología.
11. Control en servicio de urgencias en caso de necesidad. Se explican situaciones de reconsulta.

EXÁMENES Y RESULTADOS

- 24/02/24 Glic 124, Creat 1.0, MDRD 54.5, Uremia 82, ELP 144/4.1/111, Hb 14.2, Hto 42.4, Leuco 9900, Plaq 285.000, VHS 38, PCR 12.7, Lactato 0.7. INR 1.06, TTPa 28. Procalc 0.04
- 21/02/24 Glic 175, Creat 1.0, MDRD 54.5, Uremia 56, ELP 143/4.0/111, Hb 13.1, Hto 38.3, Leuco 9000, Plaq 276.000, PCR 26.8, ColT 194, HDL 65, LDL 107, TGL 111. INR 1.06. TTPa 29
- 20/02/24 angioTC de encéfalo: Hematoma sin cambios respecto a TC de encéfalo previo. En fase angiográfica sin elementos sospechosos de vasculitis o trombosis venosa profunda.
- 20/02/24 TC de encéfalo sin contraste: hematoma agudo lobar fronto cingulado derecho 30mm x 18 mm x 16 mm (3.2 cc) asociado a escasa HSA sulcal parietal superior izquierda. Areas de encefalomalacia frontal basal bilateral y temporal anterior (posible post traumática).
- 20/02/24 Glic 115, Creat 0.8, MDRD 70.5, Uremia 56, ELP 141/3.9/109, HB 13.1, Hto 39.4, Leuco 7600, Plaq 249.000, INR 0.98, TTPa 30. PCR 16.1, ColT 186, HDL 65, LDL 104, TGL 85.

OBSERVACIONES:

Al examen neurológico al alta:
SV FC 79 lpm RR, T° 36.6 °C, PA 122/92 mmHg, Sat 97% amb, HGT 107 mg/dL
- Vigil, parcialmente orientada en espacio, desorientada en tiempo, inatenta, sin alteración lenguaje, sin disartria.
- Pupilas isocoricas, RFM +/+, CV normal. OCM normal. Sensibilidad facial normal. mueca simétrica. Protruye lengua en linea media
- Hemiparesia izquierda, braquial mínima paresia logra M5. Crural izquierda M4-. ROT normales. Plantar extensor izquierdo.
- Sin alteración sensitiva
- Coordinacion no coopera
- Signos meningeos negativos.

Christian Alejandro Norambuena Aguayo
MEDICO TRATANTE
16447719-3

JEFE SERVICIO